

POLYGRAPHIE DU SOMMEIL

RAPPORT CLINIQUE D'ANALYSE VENTILATOIRE ET OXYMÉTRIQUE

Exploration ambulatoire conforme aux recommandations SFRMS / AASM (v2.6)

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue – Allergologue
N° d'Ordre : 0535/24

☎ 0663 755 584 ✉ selma.bakha@hotmail.com

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi (en face des urgences), Guelma



IDENTIFICATION DU PATIENT ET MODALITÉS DU TEST

Nom & Prénom :	KAIDI AISSA	Identifiant Examen :	20260929-142
Âge :	77 ans	Date d'enregistrement :	29 Septembre 2026
Genre :	Masculin	Créneau analysé :	23 :05 – 06 :05 (UTC+1)
Poids / Taille :	88 kg / 170 cm	Durée d'enregistrement :	420,0 min (7h 00min)
Indice de Masse Corp. :	30,5 kg/m ²	Durée valide exploitable :	420,0 min (100,0%)



Téléchargement Immédiat du Rapport Médical (PDF)

Scannez ce QR code avec votre appareil photo pour ouvrir et télécharger directement le compte-rendu médical officiel complet au format PDF.

1. TRACÉ CHRONOLOGIQUE ET CINÉTIQUE MULTICANALE

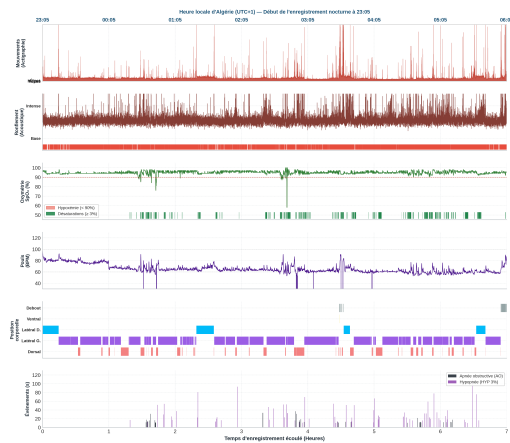


FIGURE 1 – Enregistrement polygraphique continu nocturne (23 :05–06 :05, Heure locale) : Démonstration de l’effondrement oxymétrique préférentiel en décubitus dorsal avec nadir critique à 76% et tachycardie réflexe post-apnéique à 96 bpm.

2. ANALYSE SECTORIELLE DES ÉVÉNEMENTS DU SOMMEIL

2.1. Distribution Posturale et Impact sur la Sévérité Événementielle

Position Corporelle	Durée (min)	% Temps	Hypop.	AO	AC	Désat.	IDO (/h)	Sévérité
Décubitus Dorsal (SUP)	66,1	15,7%	13	5	9	31	28,1	Sévère
Décubitus Latéral Gauche	301,9	71,9%	47	58	4	79	15,7	Modéré
Décubitus Latéral Droit	44,4	10,6%	2	0	1	2	2,7	Normal
Érigée / Assise (STAND)	7,4	1,8%	1	0	0	1	8,1	Léger
Décubitus Ventral (PRO)	0,2	< 0,1%	0	0	0	0	0,0	Normal
Total / Moyenne Globale	420,0	100,0%	63	63	14	113	16,1	Modéré

2.2. Cinétique Oxymétrique et Quantification de la Charge Hypoxique

Paramètre Oxymétrique	Valeur Observée	Norme Physiologique	Interprétation Clinique
Saturation Moyenne en O ₂ (SpO ₂)	95,0 %	≥ 95,0 %	Normale à l'état vigile/basal
Nadir Oxymétrique Physiologique (SpO ₂ min)	76,0 %	≥ 90,0 %	Désaturation ponctuelle profonde
Index de Désaturation en Oxygène (IDO global)	16,1 /h	< 5,0 /h	Hypoxémie cyclique modérée
Index de Désaturation Dorsal (IDO dorsal)	28,1 /h	< 5,0 /h	Aggravation critique sur le dos
Durée cumulée sous événement hypoxique	78,2 min (18,6%)	< 5,0% du temps	Stress hypoxique itératif prolongé
Durée moyenne d'une désaturation (Δt)	41,5 s	< 20,0 s	Inertie de clairance post-apnée
Temps passé sous 90% de SpO ₂ (T90)	3,1 min (0,8%)	< 1,0% du temps total	Absence d'hypoxémie nocturne fixée
Aire totale désaturative ($\sum \text{Area}_k$)	153,02 %-min	–	Intégrale de désaturation nocturne
Charge Hypoxique (<i>Hypoxic Burden</i> , Azarbarzin)	21,86 %-min/h	< 15,0 – 20,0	Sur-risque cardiovasculaire significatif

2.3. Caractérisation Phénotypique des Événements Ventilatoires

Nature de l'Événement	Nombre	Index (/h)	Durée Moyenne	Durée Maximale
Apnées Obstructives (AO / SAOS)	63	9,0 /h	16,1 s	33,0 s
Apnées Centrales (AC)	14	2,0 /h	15,8 s	24,5 s
Apnées Mixtes (AM)	0	0,0 /h	–	–
Hypopnées Obstructives	63	9,0 /h	21,9 s	84,3 s
Index d'Apnées-Hypopnées (IAH)	140 totaux	20,0 /h	18,7 s	84,3 s

3. TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE & BIOMARQUEURS

Biomarqueur Clé	Valeur	Biomarqueur Clé	Valeur
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	20,0 /h	Indice de Ronflement	0,7 /h
Index de Désaturation (IDO)	16,1 /h	Index d'Apnées Centrales	2,0 /h (14 au total)
Charge Hypoxique (<i>Hypoxic Burden</i>)	21,86 %-min/h	Fréquence Cardiaque Moyenne	65,5 bpm
SpO ₂ Minimale (Nadir)	76,0 %	Écarts FC (Min / Max)	53 / 96 bpm
Temps passé sous 90% (T90)	0,8 % (3,1 min)	Micro-mouvements / Agitation	308 transits

4. AVIS MÉDICAL& STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

🔍 1. Analyse Somnologique et Physiopathologique Intégrée

- **Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) d'intensité modérée (IAH = 20,0/h) :** L'enregistrement (23 :05–06 :05) objective 140 événements respiratoires significatifs induisant un IDO à 16,1/h et une sévère instabilité autonome nocturne (308 mouvements positionnels de remaniement).
- **Phénotype Positionnel Critique (POSA type 1) & Pression Critique (P_{crit}) :** Dépendance posturale majeure. En décubitus dorsal, l'affaissement lingual et le transfert liquidien rostral favorisé par l'IMC de 30,5 kg/m² élèvent la pression de collapsus, portant l'**IDO dorsal à 28,1/h** (stade sévère). En regard, le **décubitus latéral droit normalise l'aérodynamique pharyngée (IDO = 2,7/h)**.

📌 2. Conclusion Diagnostique

SAOS Modéré (IAH = 20,0/h – IDO = 16,1/h) à phénotype postural strict (dorsal : 28,1/h vs latéral droit : 2,7/h), associé à une **charge hypoxique cardiovasculairement significative (21,86 %-min/h)** et un contingent central postural chez un patient de 77 ans avec obésité de classe 1.

3. Conduite à Tenir et Prescription Thérapeutique

- Appareillage par Pression Positive Continue (PPC / Auto-CPAP) en 1^{ère} intention :**
 - Prescription d'une **Auto-CPAP** avec humidification chauffante.
- Thérapie Positionnelle Immédiate (Anti-Décubitus Dorsal) :**
 - Port d'un dispositif postural mécanique (ceinture ou gilet anti-dorsal) afin d'exploiter la rémission complète observée sur le côté droit.

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue – Allergologue
N° d'Ordre : 0535/24

Signature et cachet :